EILANTRAG NACH § 86b ABS. 2 SATZ 2 SGG (REGELUNGSANORDNUNG)

An das

Sozialgericht Braunschweig

Wilhelmstraße 55

38100 Braunschweig

(Telefax für Rechtssachen: 05141 / 5937-31600)

(EGVP-ID: govello-1272982110140-000216760)

Antragstellerin:

Alina Steinhauer, Carl-Goerdeler-Ring 26, 38518 Gifhorn

geb. am 01.09.1993, Versichertennummer: O603571189

E-Mail: alina.stone@t-online.de

Antragsgegnerin:

BKK firmus, Körperschaft des öffentlichen Rechts,

vertreten durch den Vorstand Dirk Harrer,

Gottlieb-Daimler-Str. 11, 28237 Bremen

(Tel: 0421 64343 · Fax: 0421 6434-451 · E-Mail: impressum@bkk-firmus.de)

Verfahren: Einstweiliger Rechtsschutz gem. § 86b Abs. 2 SGG

Dringlichkeit: Akute existenzielle Notlage / Drohende Zahlungsunfähigkeit & Verlust des Eigenheims

---

ANTRÄGE:

Im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes beantragt die Antragstellerin:

1. **Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin vorläufig bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Widerspruch vom 01.10.2026 gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 01.10.2026 Krankengeld in gesetzlicher Höhe ab dem 03.08.2026 (nach Ablauf der 6-wöchigen Leistungsfortzahlung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 146 SGB III; hilfsweise ab dem 20.07.2026 bzw. 13.07.2026 unter Anrechnung des für den Überschneidungszeitraum bezogenen Arbeitslosengeldes), höchsthilfsweise als vorläufige Leistung gemäß § 43 SGB I, binnen 3 Tagen ab Beschlussfassung auszuzahlen.**

2. **Die Antragsgegnerin trägt die außergerichtlichen Kosten der Antragstellerin.**

BEGRÜNDUNG:

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin ist bei der Antragsgegnerin gesetzlich krankenversichert (Vers.-Nr.: O603571189).

Vom **22.06.2026 bis zum 12.07.2026** befand sich die Antragstellerin in stationärer Krankenhausbehandlung in den MVZ Dr. Lubos Kliniken München (Klinik Bogenhausen). Am 23.06.2026 wurde dort ein hochkomplexer, mehrstündiger geschlechtsangleichender chirurgischer Eingriff (GA-Großoperation: Penektomie, beidseitige Orchiektomie, Rekonstruktion Neovagina und Vulva) durchgeführt.

Bei der Entlassung am 12.07.2026 stellte die Klinik eine lückenlose Krankenhaus-Entlass-AU bis zum **19.07.2026** aus.

Bereits am **17.07.2026** (und somit nahtlos vor Ablauf der vorherigen Bescheinigung) wurde die fortdauernde Arbeitsunfähigkeit durch die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dorothea Jung / Dr. Schmidt in Leiferde festgestellt und per elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) an die Antragsgegnerin übermittelt. Die Arbeitsunfähigkeit besteht ununterbrochen bis zum heutigen Tage fort.

Bis zum **02.08.2026** erbrachte die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 146 Abs. 1 SGB III die gesetzliche Leistungsfortzahlung des Arbeitslosengeldes im Krankheitsfall (für die gesetzliche Höchstdauer von exakt 6 Wochen bzw. 42 Kalendertagen ab dem Tag der stationären Aufnahme am 22.06.2026). Mit Ablauf des 02.08.2026 endete diese Leistungsfortzahlung kraft Gesetzes. Seit dem **03.08.2026** ist die Antragsgegnerin gesetzlich zur Auszahlung des Krankengeldes verpflichtet. Seit diesem Tage – mithin seit über zwei Monaten – verweigert die Antragsgegnerin jegliche Zahlung.

Mit Schreiben bzw. Bescheid vom 01.10.2026 (**Anlage K01**) verweigerte die Antragsgegnerin die Auszahlung des Krankengeldes ab der Entlassung mit der Behauptung, bezüglich der Diagnose F64.0 liege eine frühere Aussteuerung vor. Hiergegen legte die Antragstellerin am 01.10.2026 fristgerecht Widerspruch ein (**Anlage K02**), welcher per Einschreiben zugestellt wurde (**Anlagen K03a, K03b**). Die gesetzte Frist zur Abhilfe zum 08.10.2026 ließ die Antragsgegnerin fruchtlos verstreichen.

Stattdessen teilte die Antragsgegnerin am 07.10.2026 lediglich beiläufig mit, dass die Akte „jetzt beim Medizinischen Dienst“ (MD) liege. Zahlungen wurden verweigert.

II. Die institutionelle Zwickmühle – Verweigerte Kausalitätsatteste durch Hausarzt und Klinik

Die existenzielle Not der Antragstellerin wird durch eine völlig unverschuldete institutionelle Blockade verschärft:

* **Hausarztpraxis Dorothea Jung (Leiferde):** Die Hausärztin bestätigt und übermittelt zwar weiterhin lückenlos die Arbeitsunfähigkeit per regulärer eAU. Jedoch hat die Praxis die Unterzeichnung einer von der Antragstellerin vorformulierten gesonderten sozialmedizinischen Stellungnahme (**Anlage K04**) ausdrücklich verweigert. Die Praxis begründete dies mit massiver Sorge vor rechtlichen Konsequenzen, Regressansprüchen und Konflikten mit der Krankenkasse. Dr. Schmidt versuchte am 05.10.2026 telefonisch bei der BKK firmus Aufklärung zu leisten, wurde jedoch von der Kasse abgewiesen.

* **Dr. Lubos Kliniken München:** Auf das dringende Ersuchen der Antragstellerin vom 07.10.2026 (**Anlage K05**) teilte die Klinikleitung mit Schreiben vom 08.10.2026 (**Anlage K06**) mit, dass nachträgliche Diagnoseschlüssel-Bescheinigungen aus haftungs- und berufsrechtlichen Gründen nicht ausgestellt werden, die vorhandenen medizinischen Unterlagen und OP-Befunde jedoch ausdrücklich

für das Sozialgericht freigegeben sind.

Die Antragstellerin ist somit zwischen einer rigoros zahlungsunwilligen Krankenkasse und Ärzten gefangen, die aus haftungsrechtlicher Furcht keine individuellen Kausalitätsbestätigungen abgeben wollen, obwohl die schwere somatische Operationsfolge offenkundig ist.

III. Anordnungsanspruch

Der Anspruch auf Krankengeld ergibt sich aus §§ 44, 46, 48 SGB V. Die Arbeitsunfähigkeit ist lückenlos ärztlich bescheinigt.

Die Rechtsauffassung der Antragsgegnerin, die Arbeitsunfähigkeit nach einer derart massiven geschlechtsangleichenden Operation beruhe auf derselben, angeblich ausgesteuerten psychischen Indikationserkrankung (F64.0), ist evident fehlerhaft. Bei der postoperativen Arbeitsunfähigkeit handelt es sich um eine rein somatische Rekonvaleszenz (ausgedehntes Gewebetrauma im Beckenbereich, Wundheilung, schwere Einschränkung der Sitz- und Stehfähigkeit, u. a. ICD-10 Z98.8, T81.8, R52.2).

Selbst wenn die Antragsgegnerin den Medizinischen Dienst einschaltet, darf dies nach gefestigter Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (u. a. BSG, Urteil vom 16.12.2014 – B 1 KR 25/14 R) nicht zur völligen Mittellosigkeit der Versicherten führen. Die Antragsgegnerin ist nach **§ 43 SGB I zwingend verpflichtet, vorläufige Leistungen** zu erbringen.

IV. Anordnungsgrund (Eilbedürftigkeit / Drohender Verlust des Eigenheims)

Die Eilbedürftigkeit ergibt sich aus der akuten wirtschaftlichen Notlage der Antragstellerin:

1. Aktueller Kontostand und unabweisbare monatliche Fixkosten:

Auf dem Girokonto der Antragstellerin befindet sich per 08.10.2026 lediglich noch ein Restbetrag von **1.519,09 €** (Kontoauszug **Anlage K07**). Dem stehen unvermeidbare monatliche Zahlungsverpflichtungen gegenüber:

Kostenposition	Monatlicher Betrag	Verbindlichkeit / Gläubiger
Hauskredit (Eigenheim)	**546,00 €**	Volksbank eG – Finanzierung des selbstbewohnten Eigenheims
Gesetzlicher Kindesunterhalt	**355,00 €**	Unterhaltsverpflichtung für den minderjährigen Sohn Noah (§ 1601 BGB)
Haus-Nebenkosten & Energie	ca. **220,00 €**	Strom, Wasser/Abwasser (LSW), Grundabgaben, Wohngebäudeversicherung
Kfz & notwendige Mobilität	ca. **80,00 €**	Kfz-Versicherung & Fahrten zur ärztlichen Wundnachsorge
Lebensnotwendiger Bedarf	ca. **400,00 €**	Ernährung, Körperpflege, Zuzahlungen zu Verbandsmitteln/Medikamenten
Gesamte monatliche Existenzkosten	**ca. 1.601,00 €**	Monatliche Belastung übersteigt das Restguthaben!

2. Drohende Zwangsversteigerung des Eigenheims & Unterhaltspflichtverletzung:

Die Antragstellerin bewohnt keine Mietwohnung, sondern trägt die Verantwortung für ein **eigenes Haus**. Bei Ausbleiben des Krankengeldes drohen binnen kürzester Zeit der Rückstand der Darlehensraten, die Kündigung der Immobilienfinanzierung durch die Bank und letztlich die Zwangsversteigerung des Eigenheims. Zudem ist die Antragstellerin gesetzlich verpflichtet, den Unterhalt für ihr Kind sicherzustellen.

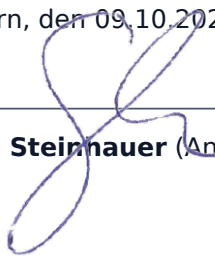
3. Unwiderrufliche Zerstörung der Existenzgründung (§ 93 SGB III):

Die Antragstellerin hat ihre berufliche Zukunft in der Selbstständigkeit („Mein Seelenfunke“, geplanter Gründungsstart: 01.11.2026) vollständig vorbereitet. Gemäß § 93 Abs. 2 Nr. 1 SGB III setzt der für den Start überlebensnotwendige Gründerzuschuss voraus, dass am Tag der Gründung noch ein **Restanspruch auf Arbeitslosengeld (ALG 1) von mindestens 150 Tagen** besteht. Würde die Antragstellerin nunmehr gezwungen, sich aufgrund der Krankengeldverweigerung arbeitslos zu melden, würde diese 150-Tage-Grenze binnen weniger Wochen unterschritten. Der Anspruch auf den Gründerzuschuss wäre für immer verloren und die berufliche Existenz vernichtet.

V. Beweismittel- und Anlagenverzeichnis

Anlage	Bezeichnung / Inhalt
Anlage K01	Bescheid der BKK firmus über Krankengeld-Verweigerung vom 01.10.2026
Anlage K02	Widerspruch der Antragstellerin vom 01.10.2026 mit Fristsetzung zum 08.10.2026
Anlage K03a/b	Zustellnachweis (Lieferschein und Einschreiben-Einlieferungsbeleg RT613794858DE)
Anlage K04	Der Hausarztpraxis vorgelegte sozialmedizinische Stellungnahme (Unterzeichnung verweigert aus Furcht vor Kassenregress; Krankschreibung wird laufend per eAU fortgeführt)
Anlage K05	Dringendes sozialmedizinisches Klarstellungsschreiben an Dr. Lubos Kliniken München vom 07.10.2026
Anlage K06	Antwort Dr. Lubos Kliniken München (Büroleitung Geschäftsführung S. Kopmann) vom 08.10.2026 mit Freigabe der Befunde für das Sozialgericht
Anlage K07	Aktueller Kontoauszug der Volksbank eG per 08.10.2026 (Restguthaben 1.519,09 € bei monatlichen Fixkosten von ca. 1.600 €)
Anlage K08	Chronologische Gesamttimeline über OP-Verzögerung, Aussteuerungsbescheid und Krankengeldverlauf
Anlage K09	Rechtliche Würdigung & Maßgebliche Rechtsprechung (BSG, LAG Berlin-Brandenburg, Hess. LSG zu § 48 SGB V, § 275 SGB V und AGG)

Gifhorn, den 09.10.2026



Alina Steinhauer (Antragstellerin)